

AAMIA · RESUMEN TEMÁTICO 4 DE 5

Movimiento, movilidad y capacidad funcional

Actividad adaptable, fuerza, equilibrio, estiramientos y prevención de caídas

actividad física	movilidad	fuerza
------------------	-----------	--------

Audiencia: Personas mayores, familias, cuidadores y facilitadores de actividad

Uso responsable

Este documento organiza y resume una biblioteca local. No diagnostica, no prescribe y no sustituye una valoración profesional. Las fuentes originales son la evidencia canónica; las referencias usan la página física del PDF.

Edición 1.0 · Julio de 2026 · Proyecto AAMIA

Cómo usar este resumen

Está diseñado para recuperación aumentada: cada apartado concentra una intención de búsqueda y conserva referencias legibles. Para decisiones importantes se consulta la fuente original y al equipo profesional.

Campo	Valor
Tema principal	Movimiento, movilidad y capacidad funcional
Temas de recuperación	actividad física, movilidad, fuerza, equilibrio, estiramientos, yoga en silla, motricidad, caídas
Tipo de fuente	Resumen secundario; remite a evidencia original
Riesgo clínico	Mixto: educativo con señales de consulta y urgencia
Contexto Markdown	Usado para redactar; no es documento indexado

Principios de síntesis

- Moverse con regularidad importa más que alcanzar una cifra perfecta desde el primer día.
- El programa se adapta a capacidad, diagnósticos, síntomas, preferencias y entorno.
- Fuerza, equilibrio, resistencia, movilidad y coordinación se complementan.
- Dolor agudo, falta de aire intensa, desmayo o debilidad súbita obligan a detenerse y pedir ayuda.

Jerarquía de uso

- 1) localizar el tema; 2) recuperar los fragmentos originales; 3) responder indicando documento y página;
- 4) reconocer cuando la biblioteca no basta.

1. Movimiento como parte de la autonomía

La actividad puede apoyar función, salud mental, participación y confianza, incluso sentada o con apoyo.

- Integrar caminatas, levantarse de una silla, tareas adaptadas, baile, juegos o ejercicios supervisados.
- Evitar largos periodos de inactividad sin indicación clínica.
- Relacionar el ejercicio con objetivos: llegar al baño, cocinar, salir o conservar una actividad apreciada.
- Celebrar regularidad y participación, no rendimiento ni comparación.

Beneficios y personalización en [R1, p. 5], [R2, p. 65], [R3, p. 30] y [R8, pp. 46-47].

2. Antes de comenzar o progresar

Una persona sedentaria puede iniciar con periodos breves, pero ciertas situaciones requieren valoración previa.

- Consultar ante caída reciente, dolor no explicado, mareo, desmayo, falta de aire inusual o enfermedad descompensada.
- Revisar calzado, espacio, temperatura, iluminación, hidratación permitida y estabilidad del apoyo.
- Elegir una intensidad que permita hablar con algo de esfuerzo y progresar gradualmente.
- Si necesita asistencia, definir quién supervisa y cómo evitar que también caiga el cuidador.

Seguridad general en [R1, p. 5], [R10, p. 94] y [R11, p. 28].

3. Componentes y estructura de sesión

Resistencia, fuerza, equilibrio, coordinación y movilidad apoyan tareas distintas. Una sesión sube y baja intensidad progresivamente.

- Inicio: comprobar cómo se siente, explicar el objetivo y realizar movimientos suaves.
- Parte principal: trabajar uno o varios componentes con pausas y apoyos.
- Vuelta a la calma: reducir ritmo, respirar cómodamente y observar recuperación.
- Registrar actividad, duración, esfuerzo, síntomas y ajustes para la siguiente sesión.

Las tres partes se describen en [R2, pp. 94-95] y [R3, p. 29].

4. Estiramientos con control

Un estiramiento debe sentirse como tensión moderada, no como dolor agudo ni competencia.

- Mantener postura estable, respiración fluida y movimientos lentos; evitar rebotes no planificados.
- No forzar articulaciones o posiciones complejas sin supervisión.
- Osteoporosis, prótesis, cirugía reciente o alteraciones neurológicas requieren indicaciones individuales.
- Detenerse ante dolor punzante, hormigueo nuevo, pérdida de fuerza, mareo o inestabilidad.

Tipos de estiramiento en [R4, p. 40]; precauciones en [R5, pp. 13-14 y 103].

5. Actividad en silla y apoyos

La silla amplía participación, pero debe ser estable y formar parte de una adaptación consciente.

- Usar silla firme, sin ruedas y sobre superficie estable; evitar mobiliario móvil como apoyo.
- Ajustar amplitud, palancas y tiempo; mantener posición segura y respiración cómoda.
- Revisar bandas, bloques y materiales; no improvisar objetos inestables.
- Yoga en silla y ejercicios sentados son opciones, no sustitutos universales de rehabilitación.

Adaptaciones revisadas en [R6, pp. 7, 17, 34 y 38].

6. Equilibrio, coordinación y juegos

Los ejercicios multicomponente pueden mejorar función y reducir riesgo de caída cuando son progresivos y sostenidos.

- Practicar cerca de apoyo estable y con supervisión cuando exista riesgo elevado.
- Progresar una variable a la vez: base, velocidad, dirección, alcance o tarea cognitiva.
- Los juegos integran movimiento, memoria, comunicación y relación social si se adaptan.
- Después de una caída, buscar causas y recuperar confianza con un plan; evitar todo movimiento perpetúa el miedo.

Equilibrio en [R7, pp. 2 y 5-6]; juegos integrados en [R3, pp. 214 y 312].

Orientación por nivel de acción

Esta tabla no es un sistema de triaje. Resume una respuesta conservadora a cambios comunes y señales de peligro.

Nivel	Situación	Acción
Continuar adaptando	Esfuerzo moderado, respiración controlada y recuperación esperada.	Mantener técnica, pausas y progresión gradual.
Detener y consultar	Dolor nuevo, mareo recurrente, fatiga desproporcionada, caída o pérdida de capacidad.	Suspender progresión y solicitar valoración.
Atención urgente	Dolor torácico, falta de aire intensa, desmayo, debilidad súbita, habla alterada o caída con lesión grave.	Activar emergencias locales.

Regla de seguridad

Cuando el cambio es súbito, intenso, empeora rápido o la persona no puede mantenerse a salvo, se prioriza ayuda humana inmediata sobre la consulta al RAG.

Qué debe conservar una respuesta de AAMIA

- Diferenciar educación general de indicaciones personalizadas.
- Mostrar fuentes originales y páginas que sostienen la respuesta.
- Declarar incertidumbre, antigüedad o desacuerdo entre fuentes.
- No transformar procedimientos clínicos en instrucciones domésticas.
- Recordar que autonomía, preferencias y contexto importan.

Fuentes utilizadas

Las páginas son páginas físicas del PDF. Las referencias documentan conceptos centrales; no implican adoptar toda afirmación de la fuente.

Criterio editorial

Se priorizaron recomendaciones convergentes, prudentes y aplicables. Las fuentes antiguas o especializadas se conservaron como contexto cuando requerían corroboración actual.

[R1] AAMIA_guia_abierta_para_el_cuidado.pdf

Páginas PDF: 5. Tipo: Guía abierta.

[R2] Tercera edad actividad física y salud (Pont Geis, Pilar).pdf

Páginas PDF: 65, 94-95. Tipo: Libro de actividad física.

[R3] Juegos de motricidad para la tercera edad (Cancela Carral, José María).pdf

Páginas PDF: 29-30, 214, 312. Tipo: Libro de actividades.

[R4] Anatomía estiramientos para la tercera edad (Portal Torices, María José).pdf

Páginas PDF: 40. Tipo: Libro de estiramientos.

[R5] Ejercicios De Estiramiento Para Mayores De 60 Años Ejercicios Simples Para Recuperar La Flexibilidad, Reducir La Rigidez,... (Michael Smith).pdf

Páginas PDF: 13-14, 103. Tipo: Guía práctica.

[R6] Yoga en silla para mayores de 60 años Ejercicios sencillos para vivir sin dolor, recuperar el equilibrio, la flexibilidad y la... (Michael Smith Nathalie Seaton).pdf

Páginas PDF: 7, 17, 34, 38. Tipo: Guía práctica.

[R7] Ejercicios de equilibrio y coordinación en el adulto mayor con riesgo de caída.pdf

Páginas PDF: 2, 5-6. Tipo: Artículo original, 2021.

[R8] Estimulación múltiple en adultos mayores estrategias (Arévalo Herrera, Diana M.).pdf

Páginas PDF: 46-47. Tipo: Manual de intervención.

[R9] Cambios-fisiol-gicos-asociados-al-envejeci_2012_Revista-M-dica-Ci-nica-Las-C.pdf

Páginas PDF: 7. Tipo: Revisión clínica, 2012.

[R10] MANUAL_BASICO_CUIDADO_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES_16_JULIO_221021.pdf

Páginas PDF: 94, 121. Tipo: Manual institucional.

[R11] Manual_cuidados-generales.pdf

Páginas PDF: 28. Tipo: Manual práctico.

Contexto editorial no indexado

Estos Markdown ayudaron a contrastar lenguaje y necesidades domésticas. No se incorporan al índice ni a la carga pública.

- Transcripción video de YouTube - Cuidado básico del adulto mayor webinar.md (actividad, independencia y fragilidad; no indexado).